



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : عليه مخلوف جاد عبد النبي
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : عين شمس العنوان :
رقم البطاقة : 28004262300588 رقم التليفون : 01013820832 تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 26-04-1980 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (.....) المقر بما فيه
التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: التوقيع:
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عليه مخلوف جاد عبد النبي National ID: 28004262300588	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

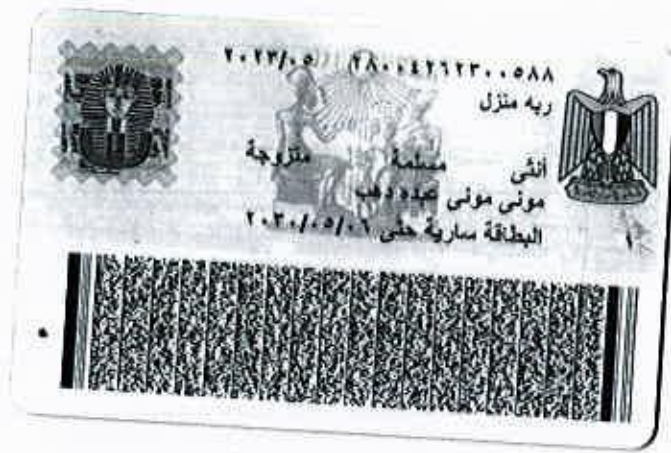
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



DMS

مَقْلُوعِيَّة

أَهْلَاءُ وَفُتُوهُمَات





GUSTAVE / ROUSSY

جوليتي
جوليتي

ECHO REPORT

NAME:

جوليتي

DATE: 22/1/2026

ID NUMBER: 2689 / 2023

SEX: Q AGE: 45y

EF	55-75%	PWT	0.6-1.1cm
LVEDD	3.5-5.8cm	AO.R	3-3.7cm
LVEDS	2-4cm	LA	2-4cm
FS	25-45%	RV	0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.6-1.1cm	AO.CUSP	1.5-2.6cm

LV Dimensions

LV Wall Thickness

LV Diastolic Function

SWMA

LA and Ao Root Dimensions

Mitral Valve

Aortic Valve

Tricuspid Valve

Pulmonary Valve

Right Side and Systolic Function

Intracardiac Masses and Effusion

DR.

Name : ALIA MAKHLOF GAD

Branch : Portable

Ref.Physician Prof : CT CAP+C

Date : 22-02-2026 10:41

Medical No. : GRI-46153

Ins.Company :

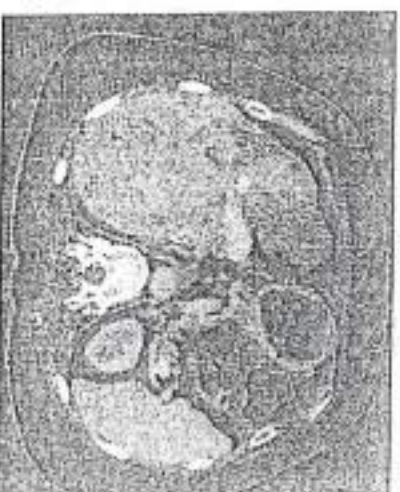
**MULTI-DETECTOR C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS FOLLOWING ORAL AND
INTRAVENOUS CONTRAST MEDIA ADMINISTRATION
REVEALED:**

Clinical data: left mastectomy for cancer breast

- Numerous hypodense poorly enhancing focal hepatic lesions the largest at segment II & III measuring 7.5x5.5 cm...metastatic liver deposits
- Normal lung parenchyma, showing no focal lesions.
- Normal vascular mediastinal structures.
- The trachea, main stem bronchi as well as their lobar and segmental divisions are normal.
- No evidence of mediastinal or hilar nodal enlargement .
- No pleural collections.
- No detectable lesions in the chest wall.
- The intra and extra-hepatic biliary radicles are normal.
- The pancreas and spleen are normal.
- Normal CT features of both kidneys.
- Right and left supra renal glands are normal.
- No CT evidence of enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.
- No ascites.
- Scans through the pelvis showed no masses.
- No suspicious focal lesions

Opinion

- Multiple bilobar metastatic liver deposits



Much Obliged;
Dr.Khaled Moghazy,MD
Prof.of Radiology

MDT FORM

1 / 2 / 20 26 G

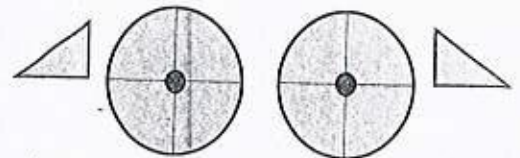
Name	علي مخلوف جاد	MRN	٢٦٨٩ / ٤٢
Age	45 yr	ID	٢٨٨٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤
Menopausal status	Pre	Phone	01013820832
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity	DM → uncontrolled, Hyperglycemia = Cardiac → EF 37% → 44 → 46%	REASON OF MDT	Re MDT

Clinical Data

BX:	1DC
ER:	8/8
PR:	8/8
HER 2:	amplified
Ki67:	50%

R

L



Sonomammography:

8/2023 → TC x 6, HP x 3

due to Af 40 vs 37%

Mets Workup:

3/24 → left MRM (T4b N2 Mo) TNM

Adj Portin + AI + Zoladex

10/25 → CT → HFL → Bx → ER 8/8 PR 3/8 her-2 + met carcinoma of breast origin

Recommendations:

CT films Revi for Taxol / Herceptin per 10/25
MDT due to high burden disease or Taxol / Tykerb
if EF ↓. Last Echo EF 47% (previously 37%)

pt has dyspnea at Rest + orthopnea + PND
Uncontrolled diabetic ~ 400 FBS, has PVD, unstable gait
+ unable to use hands. Received only 3 weeks of Taxol & No
for plan of magistral anti-HER-2

MDT OUTCOME & PLAN

In view of grade III → IV Nephropathy

→ shift to Kebab + Herceptin IV w/ close follow up

Plan for a New CT - Scan about 10/26

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

atient Name : الأستاذ / عليه مخلوف جاد عبد النبي
atient No. : 28004262300588
ath No. : 3100/25
ex : Female
ge : 45 Y
eferreing Doc :

Request No. : 13005157
Request Date : 09/10/2025
Verification Date : 28/10/2025
Financial Category : جوستاف روسمي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Ki67%: 60%.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

ISH groups:

The ratio is calculated and the results is interpreted as:

- Group I (Positive): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4.
- Group II (Negative): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4. (Recounting give the same result).
- Group III (Positive): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 6 (Recounting give the same result).
- Group IV (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4 but less than 6. (Recounting give the same result).

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 11/11/2025 10:32:34

Page 2 of 3

Printing By : Ali mostafa



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name: Aleya Makhlouf Gad A. Naby	Date : 26/04/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 45 Year(s)
Medical ID: 2689/2023	Pat. ID: 46153

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The right breast is scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- Right LOQ well-circumscribed oval shaped lesion. US showed 8:00 well-circumscribed hypoechoic oval shaped solid lesion measuring 2.9x1 cm
- Right UOQ IMLN
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Right stationary benign looking solid lesion (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Yasmin Nada
26/04/2025 11:16 AM



Echo report

عليه مخلوف جاد

MR: ٢٦١٩
٢٢

Name:

Date: 3/1/2024

EF	44%	55-75%	PWT	0.8	
LVEDD	6.3	3.5-5.8cm	AO.R	2.7	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	4.1	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	1.1	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions Dilated LV internal dimension

LV wall thickness Normal

LV diastolic function DD Grade II

SWMA Global Hypokinesia

LA and Aortic root dimensions Normal

Mitral Valve Mild TR

Aortic valve Normal

Tricuspid valve Mild TR

Pulmonary valve Normal

Right side and systolic function Normal

Intracardiac masses and effusion No

Dilated LV int dimension
Impaired LV systolic function
Ef = 40-45%
DD grade II

D/ Msc cardiology

د/عبدالله

ECHO REPORT

NAME: عليه مخلوف جاز DATE: 2 / 12 / 2025
ID NUMBER: / SEX: F AGE: 45

EF	<u>46%</u>	55-75%	PWT	<u>0.7</u>	0.6-1.1cm
LVEDD	<u>5.8</u>	3.5-5.8cm	AO.R	<u>2.5</u>	3-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	<u>4.4</u>	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	<u>0.9</u>	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV Dimensions aml

LV Wall Thickness aml

LV Diastolic Function DD grade I

SWMA SWMA in the form of global hypokinesia

LA and Ao Root Dimensions aml

Mitral Valve Mild TR

Aortic Valve aml

Tricuspid Valve aml

Pulmonary Valve aml

Right Side and Systolic Function aml

Intracardiac Masses and Effusion aml

DR.

[Signature]


 جمهورية مصر العربية
 بطاقة تعريف الشخصية

عليه
 مخلوف جاد عبد النبي
 ١٦ ميدان الجمهورية
 هابدين - القاهرة

١٩٨٠/٠٤/٢٦ ٢٨٠٠٤٢٦٢٣٠٠٥٨٨
 J22369477


 ٢٠٢٣/٠٥ ٢٨٠٠٤٢٦٢٣٠٠٥٨٨
 ربه منزل
 أنثى مسلمة متزوجة
 مولى مولى عبده ذهب
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٠/٠٥/٠٦


 ١

